

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231697062 | 170

MARIA ELIZABETH SARTORELLI

IDADE: 69 PESO: 92 ALTURA: 1,60 PROFISSÃO: Aposentada.

SINTOMAS: Refluxo;

QUEIXAS: Comaço; Desemimo; Ronco;

MEDICAMENTOS: Atacandi (HAS); Metformina (DM); Eutirox (Hipotireoidismo).

MÉDICO: Dr. Carlos Expedito de Lencastre (cardio)

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada diária

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h 23h HORA QUE ACORDA: 08h

COCHILO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S ☒ X NA SEMANA () N esporádico.

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 50 e/h SPO2: 81%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

07/10/2024 Análise auto 4 à 12 cmH₂O másc (M). Silêncio

14/10/2024 P=9,8 cmH₂O Boca seca.

IAH=2,2 e/h

m uso=9h30'

fuga=29l/min.

- começou caminhada
- iniciou dieta.
- rugas pelo / seixo auto 6 à 11 cmH₂O
+ Pressão 5 cmH₂O.

23/10/24 P=9,5 cmH₂O

IAH=1,4 e/h

m uso=8h20'

fuga=34l/min

Refere melhora dispneia.

+ vezes ao banheiro, tem diarréia que não
para

Fixo Pressão: 9,6 cmH₂O

Silêncio

14/11 P=9,6 cmH₂O

IAH=1,7 e/h

M. de uso: 7:26h

fuga

17/12/24 P = 9,6 cm H₂O
IAH = 1,8 e/h
m de uso: 7h 8'
fluxo: 37,6 l/m

Bem adaptada
Dilata Boca Rica

Natasha

18/02/25 P = 9,6 cm H₂O
IAH = 1,0 e/h
m de uso: 7h 36'
fluxo: 31,4 l/m

Oriento higiene e
ajuste de máscara

Natasha

29/04/25 P = 9,6 cm H₂O
IAH = 1,0 e/h
m de uso: 7h 42'
fluxo: 24,9 l/m

Bem adaptada

Natasha

08/07
25 P = 9,6 cm H₂O
IAH = 0,7 e/h
m de uso: 8h 37'
fluxo: 20,7 l/m

Tem 2 aparelhos, 1 em
cada cara, usa 15 dias

Natasha

02/10/25 P = 9,6 cm H₂O
IAH = 1,0 e/h
med: 8h 09 min
fluxo: 25 l/min

boca seca; higiene nasal prong

Nome: MARIA ELIZABETH SARTORELLI

Data de Nascimento: 9-1-1955

IMC: 35,94

Sexo: Feminino

Data do exame: 18-09-2024

Peso: 92 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DR. CARLOS EXPEDITO LEITÃO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 18-09-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 540,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 51,5 e 109,5 minutos. O tempo total de sono foi de 468,5 min, eficiência de 86,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,5%; estágio N2: 64,6%; estágio N3: 12,8%; sono REM: 21,1%. O índice de despertares foi de 33,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 50,6/hora, sendo 29 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 261 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 81%, permanecendo 29,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 43 - 66 bpm e NREM de 42 - 73 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 50,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (3,1/hora);
8. presença de atividade em EMG de queixo;
9. registro de ronco durante o sono.

**Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado.
Presença de bruxismo ou apertamento.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157